

Glomerulonefritis Postestreptocócica

1. Introducción y relevancia clínica

La **glomerulonefritis postestreptocócica (GNPE)** es una **enfermedad inflamatoria del glomérulo renal**, causada por una **reacción inmunológica secundaria a infección por Streptococcus betahemolítico del grupo A (SBHGA)**, típicamente de origen **faríngeo o cutáneo (impétigo)**.

Es la **glomerulonefritis más frecuente en la infancia**, especialmente entre los **5 y 12 años**, y representa un modelo clásico de **enfermedad renal inmunomediada**.

Su importancia clínica radica en que **puede causar síndrome nefrítico agudo con hematuria, hipertensión y edema**, y aunque suele tener un **buen pronóstico**, requiere un **manejo cuidadoso de las complicaciones (hipertensión, sobrecarga de volumen, insuficiencia renal aguda)**.

En el **EUNACOM**, suele presentarse como un niño con **edema facial, orina color “coca-cola”, hipertensión y antecedente de faringitis 2 semanas antes**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Mecanismo inmunológico

1. Tras infección por SBHGA nefritogénico, se forman **complejos inmunes circulantes** (antígeno-anticuerpo).
2. Estos complejos se depositan en el **glomérulo (membrana basal glomerular y mesangio)**.
3. Activan el **sistema del complemento (vía clásica)** → inflamación glomerular.
4. Resulta en **proliferación celular, disminución de la filtración glomerular y hematuria**.

b. Cepas nefritogénicas

- Faringitis: tipos M1, M3, M5, M12.
- Piodermitis: tipos M49, M55, M57.

c. Período de latencia

- Faringitis: 1–3 semanas después de la infección.
- Impétigo: 3–6 semanas después.

d. Afectación renal

- Infiltrado inflamatorio difuso del glomérulo.
 - Disminución temporal de la tasa de filtración glomerular (TFG).
 - Resolución completa en la mayoría de los casos.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Cuadro clínico típico

Aparece bruscamente en un niño previamente sano, con antecedente de infección estreptocócica reciente.

Síndrome nefrítico agudo característico:

1. **Hematuria macroscópica:** orina color “coca-cola”.
2. **Edema:** primero periorbitario (matutino), luego generalizado.
3. **Hipertensión arterial:** 60–80 % de los casos.
4. **Oliguria:** diuresis disminuida.
5. **Leve proteinuria (<2 g/día).**
6. Malestar general, astenia, cefalea.

□ La tríada *hematuria + edema + hipertensión* es altamente sugestiva.

b. Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencias principales
Síndrome nefrótico (cambio mínimo)	Proteinuria masiva, sin hematuria ni hipertensión.
Glomerulonefritis rápidamente progresiva	Evolución grave, insuficiencia renal acelerada.
Nefropatía por IgA (enfermedad de Berger)	Hematuria coincide con la infección (no posterior).
Lupus eritematoso sistémico	ANA y anti-DNA positivos, compromiso multisistémico.
Púrpura de Schönlein-Henoch	Púrpura palpable, dolor abdominal, artralgias.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a.

Laboratorio

Parámetro	Hallazgo típico
EAS (orina completa)	Hematuria (eritrocitos dismórficos), proteinuria leve, cilindros hemáticos.
Complemento sérico (C3)	Disminuido (por consumo en la fase aguda). Se normaliza en 6–8 semanas.

ASO (anticuerpos antiestreptolisina O)

Elevada (indica infección reciente). No siempre positiva si infección cutánea.

Anti-DNasa B

Elevado (especialmente útil en infecciones cutáneas).

Creatinina y BUN

Elevados en casos moderados a severos.

Hemograma

Leucocitosis leve, anemia dilucional.

b.

Imágenes

- **Ecografía renal:** tamaño renal aumentado, ecogenicidad difusa.
- **Biopsia renal:** rara vez necesaria; indicada solo si:
 - No hay evidencia de infección estreptocócica.
 - C3 normal o persiste bajo >8 semanas.
 - Evolución atípica (síndrome nefrótico, anuria prolongada, HTA severa).

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / SOCHIPE 2021)

a.

Medidas generales

- **Hospitalizar si:**
 - Hipertensión moderada o grave.
 - Insuficiencia renal aguda.

- Edema generalizado o sobrecarga de volumen.
- Alteración de conciencia o cefalea intensa.

b.

Tratamiento específico

Medida	Detalle
Erradicar infección estreptocócica	Penicilina benzatina 1.200.000 UI IM (600.000 UI si <30 kg). Alternativas: amoxicilina o macrólidos.
Restricción de sal y líquidos	Según estado edematoso y diuresis.
Diuréticos	Furosemida 1 mg/kg/dosis EV o VO si hay sobrecarga de volumen.
Antihipertensivos	Captopril o nifedipino VO si PA > p95.
Control de balance hídrico	Peso diario, diuresis horaria.
Reposo relativo	Hasta normalización de PA y mejoría clínica.
Los corticoides no están indicados en GNPE no complicada.	

6. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- **Insuficiencia renal aguda (10–20 %).**

- **Hipertensión encefalopática.**
- **Edema agudo de pulmón.**
- **Convulsiones o encefalopatía hipertensiva.**
- **Cicatriz renal crónica (rara).**

b. Pronóstico

En el 95 % de los niños, la recuperación es completa en 4–8 semanas.

La **proteinuria** puede persistir algunos meses.

Solo un 1–2 % evoluciona a **nefropatía crónica**.

7. Seguimiento

- **Control de orina y PA semanal** durante la fase aguda.
 - **Complemento (C3)** debe normalizarse en 6–8 semanas.
 - **Ecografía o función renal** si curso prolongado.
 - Control anual de PA y EAS.
-

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ **Perlas:**

1. **Faringitis estreptocócica 1–3 semanas antes → GNPE.**
2. **Hematuria color “coca-cola” + edema facial + HTA = síndrome nefrítico.**
3. **C3 bajo y ASO elevado** confirman origen postestreptocócico.
4. **Tratamiento es de soporte; no se usan corticoides.**
5. **Penicilina benzatina** erradica el germen y evita contagios.
6. **Pronóstico excelente**, la función renal se recupera completamente.

7. En caso de evolución atípica, considerar **otras glomerulopatías**.

□ **Errores frecuentes:**

- Tratar con corticoides innecesariamente.
 - No restringir sodio y líquidos en edema severo.
 - No controlar presión arterial.
 - No investigar infección estreptocócica previa.
 - Asumir que toda hematuria postinfecciosa es GNPE (diferenciar con IgA).
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **GNPE:** glomerulonefritis inmunológica secundaria a infección por *Streptococcus* β -hemolítico grupo A.
2. **Latencia:** 1–3 semanas postfaringitis (o 3–6 tras impétigo).
3. **Clínica:** hematuria, edema, hipertensión, oliguria.
4. **C3 bajo y ASO alto** son diagnósticos.
5. **Tratamiento de soporte:** restricción salina, diuréticos, control PA.
6. **No corticoides** salvo evolución atípica.
7. **Pronóstico excelente:** recuperación completa en >90 % de los casos.